Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Derin Boyun Germe

Deep neck lift / derin plan boyun germe

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Planlanan işlem bileşenleri:
☐ Platizmaplasti ☐ Derin yağ alımı ☐ Digastrik kas küçültme
☐ Submandibuler bez küçültme ☐ Cilt fazlası alımı

Eşzamanlı yüz germe: ☐ Yok ☐ Var (ayrı onam formu ile) _____

Birlikte yapılacak diğer işlemler: _____

Hastanın şikâyeti ve beklentisi: _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Boyun bölgesinde yaşla, kilo değişimleriyle veya kalıtsal yapıya bağlı olarak **gıdı altında dolgunluk**, çene-boyun açısının kaybolması, boyunda **dikey bantlar** (platizma kası bantları) ve **cilt sarkması** görülebilir. Bu görünüm yalnızca cilt altındaki yağdan değil, çoğu zaman **boyun kasının altındaki derin yağdan, çene altı kaslarından (digastrik kas) ve tükürük bezlerinin (submandibuler bez) sarkmasından** kaynaklanır.

Derin boyun germe, bu derin yapıları da ele alarak çene hattını belirginleştirmeyi ve daha **genç, net ve doğal görünümlü** bir boyun elde etmeyi amaçlar. Sonuç; cildinizin esnekliğine, kemik yapınıza, kilonuza ve yaşınıza bağlıdır. Ameliyat yaşlanmayı durdurmaz; boyun zamanla yeniden gevşemeye devam eder.

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyat genellikle genel anestezi altında, ameliyathane koşullarında yapılır. Ameliyattan önce boynunuz oturarak ve ayakta muayene edilir, fotoğraflanır, işaretleme yapılır ve hangi yapıların ele alınacağı sizinle birlikte belirlenir.

1. **Kesiler:** Çene altındaki doğal kıvrıma yaklaşık 3–5 cm'lik bir kesi yapılır. Cilt fazlası alınacaksa kulak memesinin çevresinden kulak arkasına ve saç çizgisine uzanan kesiler eklenir. Kesiler mümkün olduğunca doğal kıvrımlara ve saçlı deriye gizlenir.
2. **Cildin kaldırılması:** Boyun cildi alttaki kastan nazikçe ayrılır; gerekiyorsa yüzeyel yağ dengeli şekilde inceltilir.
3. **Derin yağın alınması:** Boyun kasının (platizma) altında kalan ve dışarıdan yağ aldırma (liposuction) ile ulaşılamayan derin yağ dokusu kontrollü şekilde azaltılır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

4. **Digastrik kas ve submandibuler bez:** Çene altında dolgunluk yapan digastrik kasın ön kısmı gerekirse inceltilir. Sarkık ve belirgin tükürük bezinin (submandibuler bez) çıkıntı yapan kısmı gerekiyorsa kısmen küçültülür; bez tamamen çıkarılmaz.
5. **Platizmaplasti:** Boyun ortasında ayrılmış ve bant oluşturan platizma kasının kenarları birbirine dikilerek bir "iç korse" oluşturulur; gerekirse yanlardan askıya alınır.
6. **Cilt fazlasının alınması ve kapatma:** Cilt, gerginlik oluşturmadan yukarı ve geriye yönlendirilir, fazlası alınır. Kanama kontrolü yapılır, genellikle **dren** (ince bir sıvı boşaltma borusu) yerleştirilir, kesiler ince dikişlerle kapatılır ve boyun bandajı uygulanır.

Planlanan bileşenler kişiye göre değişir; her hastada her adım uygulanmaz. Yüz germe ameliyatı eşzamanlı yapılacaksa bunun için **ayrı bir onam formu** imzalanır.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Genel anestezi (seçilmiş hastalarda sedasyon + lokal anestezi)	Yaklaşık 2–4 saat (eşzamanlı işlemlerle daha uzun)	Genellikle 1 gece hastanede kalış

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Çene hattının ve çene-boyun açısının daha belirgin hâle gelmesi
- Gıdı altındaki dolgunluğun ve boyundaki dikey bantların azalması
- Sarkık boyun cildinin toparlanması ve daha genç, dinç bir görünüm

Uygun seçilmiş hastaların büyük çoğunluğu sonuçtan memnun kalır. Şişliğin büyük kısmı ilk 4–6 haftada geçer; nihai sonuç **6–12 ay** içinde oturur. Cilt kalitesi zayıf, ileri yaşta, çok kilo vermiş veya daha önce boyun ameliyatı geçirmiş hastalarda sonuç daha sınırlı olabilir. Yaklaşık 100 hastadan **5–10'unda** küçük bir düzeltme (rötuş) işlemi gerekebilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Ameliyat olmamak:** Estetik bir işlem olduğu için yaptırmama seçeneğiniz her zaman vardır.
- **Yalnızca gıdı liposuction:** Cilt esnekliği iyi olan ve dolgunluğu yalnızca cilt altı yağdan kaynaklanan kişilerde yeterli olabilir; derin yağı, kası ve bezleri düzeltmez.
- **Enjeksiyonla yağ eritme (deoksikolik asit) veya enerji temelli cihazlar (radyofrekans, ultrason):** Hafif dolgunluk ve gevşeklikte sınırlı iyileşme sağlar, genellikle birden fazla seans gerekir.
- **Botoks ile platizma bantlarının yumuşatılması:** Bantları geçici olarak (3–4 ay) azaltır; sarkmayı ve yağı düzeltmez.
- **Daha sınırlı boyun germe:** Yalnızca cilt fazlasını alan veya yalnızca platizmaplasti içeren daha küçük ameliyatlar; etkileri daha sınırlıdır.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Ameliyat yapılmazsa boynunuzun mevcut görünümü korunur ve yaşla birlikte doğal yaşlanma süreci devam eder. Bu durum sağlığınız için bir tehlike oluşturmaz.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Ameliyattan önce kan tahlilleri, gerekirse EKG ve diğer tetkikler yapılır; anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz.
- **Tansiyonunuzun iyi kontrol altında olması çok önemlidir.** Yüksek tansiyon, ameliyat sonrası boyunda kan birikmesi (hematom) riskini belirgin şekilde artırır. Tansiyon ilacınızı ameliyat sabahı da (az suyla) almanız gerekip gerekmediğini anestezi uzmanına danışınız.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Ameliyattan önceki **6–8 saat** boyunca hiçbir şey yememeniz ve içmemeniz gerekir (anestezi uzmanının talimatlarına uyunuz).
- Ameliyattan önce yoğun egzersiz, sauna ve aşırı alkol tüketiminden kaçınınız. Ameliyat günü makyaj, takı ve kolye kullanmayınız; önden düğmeli, boyundan geçirilmesi gerekmeyen bir giysi getiriniz.
- Ameliyattan sonraki ilk 24–48 saat size eşlik edecek bir yakınınızın olması önerilir.
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 24–48 saat	Boyunda bandaj ve dren bulunur. Boyunda şişlik, gerginlik ve yutkunurken rahatsızlık hissi olur; ağrı genellikle hafif–orta düzeydedir. Başınızı yüksekte (30–45°) tutarak yatmanız, boynu aşırı bükmemeniz ve tansiyonunuzun yükselmemesi (ıkınmama, öksürüğü kontrol etme) önemlidir. Dren genellikle **1–2. günde** çıkarılır.
1. hafta	Şişlik ve morarma olursa en belirgin dönemdir, sonra azalmaya başlar. Boyun ve çene altında uyuşukluk normaldir. Gündüz ve gece **boyun korsesi/bandajı** önerildiği şekilde kullanılır. Dikişler **5–10. günlerde** alınır.
2–4. haftalar	Çoğu hasta 10–14 gün içinde masa başı işine ve sosyal hayata döner. Boyunda sertlik, düzensizlik hissi ve gerginlik devam edebilir. Ağır egzersiz, eğilip kaldırma ve boynu zorlayan hareketler en az **3–4 hafta** ertelenmelidir.
1–3. aylar	Kalan şişlik ve sertlik yavaş yavaş azalır. Uyuşukluk büyük oranda düzelir. İzler bu dönemde pembe ve hafif kabarık olabilir.
6–12. aylar	Nihai görünüm ortaya çıkar; izler soluklaşır ve incelir. Gerekli görülürse rötuş işlemi için genellikle en az 6 ay beklenir.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Boyunda ve çene altında şişlik; morarma **olursa** 1–3 hafta içinde geçer
- Boyun cildinde ve kulak çevresinde geçici uyuşukluk
- Boyunda gerginlik, sertlik ve yutkunurken hafif rahatsızlık
- Kesi yerlerinde hafif ağrı, kaşıntı ve pembe izler
- İlk haftalarda deri altında elle hissedilen düzensizlik ve sertlikler

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Uzun süren şişlik ve sertlik** — Boyunda ve çene altında sertlik birkaç ay sürebilir; masaj ve zamanla düzelir.
- **Küçük asimetri ve kontur düzensizlikleri** — Boynun iki tarafı arasında hafif farklar veya cilt altında küçük çukurluk/kabarıklıklar kalabilir; çoğu zamanla yumuşar, bazıları küçük bir düzeltme gerektirebilir.
- **Seroma (sıvı birikimi)** — Cilt altında berrak sıvı toplanmasıdır; genellikle muayenehanede iğneyle boşaltılarak tedavi edilir.
- **Rötuş (düzeltme) ihtiyacı** — Yaklaşık 100 hastadan **5–10'unda** kalan fazlalık, düzensizlik veya iz için küçük bir düzeltme işlemi gerekebilir.

Seyrek görülen durumlar

- **Hematom (boyunda kan birikmesi)** — Yaklaşık 100 hastadan **2–5'inde** görülür; **erkeklerde ve tansiyonu yüksek olanlarda** daha sıktır ve çoğunlukla ilk 24 saatte ortaya çıkar. Küçük hematomlar iğneyle boşaltılabilir; büyük hematomlarda **ameliyathaneye geri dönülerek** kanın boşaltılması ve kanamanın durdurulması gerekir. Hızla büyüyen bir hematom **soluk borusuna baskı yaparak nefes almayı zorlaştırabilir**; bu durum acil müdahale gerektirir. Geç fark edilen hematom cilt beslenmesini bozarak yara ve iz sorunlarına yol açabilir.
- **Alt dudak hareketinde geçici zayıflık (yüz sinirinin çene kenarı / boyun dalı)** — Yaklaşık 100 hastadan **1–10'unda** gülümserken alt dudağın bir tarafında asimetri görülebilir. Büyük çoğunluğu sinirin gerilmesine veya şişliğe bağlıdır ve **birkaç hafta ile birkaç ay** içinde kendiliğinden düzelir.
- **Tükürük sızıntısı / tükürük kesesi (sialosel)** — Submandibuler bez küçültülen hastalarda bezden sızan tükürük cilt altında birikebilir. Genellikle tekrarlayan iğne ile boşaltma, baskılı bandaj ve gerekirse ilaçla düzelir; nadiren ek girişim gerekir.
- **Fazla doku alımına bağlı görünüm bozukluğu** — Çok fazla yağ veya bez dokusu alınması boyun ortasında çukurluk, kasların belirginleşmesi ve "iskeletleşmiş" görünüm ("kobra boyun" deformitesi) oluşturabilir. Düzeltilmesi yağ enjeksiyonu veya ek ameliyat gerektirebilir; bu nedenle doku alımı dengeli ve kontrollü yapılır.
- **Belirgin veya geniş iz** — Çene altı ve kulak arkası izler nadiren kalınlaşabilir, genişleyebilir veya renk değişikliği gösterebilir. Kortizonlu iğne, silikon jel veya iz düzeltme işlemiyle tedavi edilebilir. Kulak arkası kesi saç çizgisine uzanıyorsa bu bölgede saç seyrelmesi olabilir. Kulak memesi çevresinden kesi yapıldıysa kulak memesi nadiren aşağı ve öne çekilmiş görünebilir; gerekirse küçük bir düzeltme yapılır.
- **Uzun süren uyuşukluk** — Boyun ve kulak memesi çevresinde his azalması birkaç ay sürebilir; nadiren kısmen kalıcı olabilir.
- **Enfeksiyon** — 100 hastada **1'den az–2** oranında görülür. Genellikle antibiyotikle düzelir; nadiren iltihabın boşaltılması gerekir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Cilt beslenmesinin bozulması ve doku kaybı (nekroz)** — Özellikle **sigara içenlerde**, şeker hastalarında ve hematom gelişen hastalarda, cilt kenarlarında yara açılması ve doku kaybı görülebilir. İyileşme uzar, pansuman ve bazen ek cerrahi gerekir; kalıcı iz bırakabilir.
- **Kalıcı sinir hasarı** — Alt dudak hareketinde kalıcı zayıflık **100 hastada 1'den azdır**. Çok nadiren dil hareketini (hipoglossal sinir) veya dilde hissi (lingual sinir) sağlayan sinirler ya da kulak memesinin hissini sağlayan sinir (büyük kulak siniri) etkilenebilir.
- **Hava yolu sorunları ve yutma güçlüğü** — Büyük hematom veya belirgin şişliğe bağlı çok nadir durumlarda acil olarak hava yolunun güvence altına alınması ve yoğun bakım takibi gerekebilir. Derin yapıların düzeltilmesinden sonra geçici yutma güçlüğü olabilir.
- **Damar veya tükürük kanalı yaralanması** — Boyundaki toplardamarların yaralanmasına bağlı kanama veya tükürük bezi kanalına ait sorunlar çok nadirdir; ek tedavi veya girişim gerektirebilir.
- **Yeniden sarkma** — Boyun, yaşlanma ve kilo değişiklikleriyle yıllar içinde yeniden gevşeyebilir; bu bir komplikasyon değil, doğal süreçtir. Boyun kas bantları da zamanla yeniden belirginleşebilir. Erken dönemde belirgin gevşeme nadirdir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Psikolojik memnuniyetsizlik** — Teknik olarak başarılı bir sonuca rağmen kişi yeni görünümüne uyum sağlamakta zorlanabilir. Beklentilerin ameliyat öncesi açıkça konuşulması bu riski azaltır.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.
- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.
- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- Boyunda **hızla artan şişlik, gerginlik veya tek taraflı belirgin büyüme**, özellikle ilk 24–48 saatte
- **Nefes almada güçlük, ses değişikliği, yutkunamama** veya boğulma hissi (bekletmeden 112'yi arayınız)
- Bandajın altından **durmayan kanama** veya dren torbasında hızla artan kan
- **38,5 °C üzerinde ateş**, kesi yerlerinde artan kızarıklık, ağrı, ısı veya iltihaplı akıntı
- Cilt renginde **koyulaşma, morumsu-siyah renk** veya yara açılması
- Ani ve şiddetli ağrı, ilaçlara yanıt vermeyen ağrı
- Nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bacakta tek taraflı şişlik ve ağrı

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- İlk 2 hafta başınızı yüksekte tutarak sırtüstü yatınız; boynunuzu aşırı bükmekten, ani baş-boyun hareketlerinden ve öne eğilmekten kaçınınız.
- Boyun korsesini/bandajını size önerilen süre boyunca (genellikle 1–3 hafta) kullanınız.
- Tansiyonunuzu düzenli ölçünüz ve ilaçlarınızı aksatmayınız; ıkınmaktan, ağır kaldırmaktan ve öksürüğü kontrolsüz bırakmaktan kaçınınız.
- İlk 3–4 hafta ağır egzersiz, sauna, hamam ve sıcak duştan kaçınınız.
- İzleri en az 3–6 ay güneşten koruyunuz.
- Yurt dışından geldiyseniz uçak yolculuğu genellikle dren ve ilk kontroller tamamlandıktan sonra, çoğunlukla 5–7. günden itibaren güvenlidir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve “Size özel bilgiler” bölümüne yazılır.

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

- ☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa “yoktur” yazılır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.
- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Ameliyatın yaşlanmayı durdurmadığını, boynun zamanla yeniden gevşeyebileceğini ve sonucun cilt kalitem, kilom ve kemik yapımla sınırlı olduğunu anladım.
- ☐ Tansiyonumun kontrol altında tutulmasının ve ameliyat sonrası talimatlara uymanın kanama (hematom) riskini azaltmak için önemli olduğunu biliyorum.
- ☐ Bu işlemin **estetik amaçlı** olduğunu, tıbben zorunlu olmadığını ve yaptırmama seçeneğimin her zaman bulunduğunu biliyorum. Beklentilerimi hekimimle konuştum; ulaşılabilecek gerçekçi sonuç bana anlatıldı.
- ☐ Kusursuz simetri veya bir fotoğraftaki görünümün aynısının garanti edilemeyeceğini, nihai sonucun dokularımın iyileşme özelliklerine bağlı olduğunu ve bazı durumlarda düzeltme işlemi gerekebileceğini anladım.

- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**
- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.